



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : رشا انور يونس احمد
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : كرداسه
رقم البطاقة : 27810222103707 رقم التليفون : 01144626668
العنوان : قرية كفر غطاطي
العمر (تاريخ الميلاد) : 22-10-1978 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رشأ انور يونس احممد National ID: 27810222103707	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

رشا
انور يونس احمد بدوى
قرية كفر غطاظي
مركز كرداسه - الجيزه

١٩٧٨/١/٢٢ ٢٧٨ ١٠ ٢٢ ٢١ ٠٣٧ ٠٧

IM5023983

١١٤٤٦٤٦٦٦٦

٦٦٦

٩/٢٠

٢٠٢٠/٠٧ ٢٧٨١٠ ٢٢٢١٠ ٣٧٠٧

ربة منزل

انثى
مسلمة
متزوجة
احمد عبدالنبي عبيد ابو عميره
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٧/٢٦

١

اسم المريض بالإنجليزية: Rasha Anwar Yonis Ahmed	كود المريض: 100718
تاريخ التقرير: 2026/09/20 10:11:18 AM	السن: ٣٧ سنة، ١٠ شهر

Women's Health Outreach Program

High-resolution ultrasound and revision of previous bilateral mammogram.

Clinical summary: 49 years old female patient with Right breast lump with skin dimpling and nodule .

Detailed Findings

Right breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c)
- Right UOQ pathological process in form of speculated dense mass lesion measuring about 3.5 x 2.8 x 4.6 at AP, TS and CC associated with surrounding area of distortion, spiculations and asymmetry as well as skin dimpling reaching to the nipple, the whole process measuring about 5.6 x 8.5 cm
- No suspicious microcalcification
- **Ultrasound** revealed an irregular heterogenous hypoechoic mass lesion with posterior acoustic shadowing and internal vascularity seen at 9-10 O'clock measuring about 2.8 x 3.4 cm with ductal extension to the nipple and reaching to skin
- Multiple (more than three) level I enlarged pathological axillary lymph nodes with globular shape and effaced hila, the largest measuring about 1.6 x 1.3 cm with increased cortical thickness about 6 mm

Left breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- No solid or cystic lesions seen
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5):** Right UOQ highly suspicious spiculated mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. True cut biopsy is recommended
- **Aslo CESM is recommended**
- **Right breast (BIRADS 1):** normal study of the breast

Much obliged,

Dr. Rania Mostafa
Dr. Nourhan Osama, MD

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

رشا
انور يونس احمد بدوى
قرية كفر غطاظى
مركز كرداسه - الجيزه

١٩٧٨/١
٢٧٨ ١٠ ٢٢ ٢١ ٠٣٧
IM5023983

National ID - Front
[DOCTYMS-10-1-001]



٢٠٢٠/٠٧ ٢٧٨١٠٢٢٢١٠٣٧٠٧

ربة منزل



أنثى مسلمة متزوجة
احمد عبدالنبي عبيد ابو عميره
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٧/٢٦

١



Natio al Jus Socia
[[DOCTY]]

اسم المريض بالإنجليزية: Rasha Anwar Yonis Ahmed	كود المريض: 100718
تاريخ التقرير: 2026/09/20 10:11:18 AM	السن: ٢٧ سنة، ١٠ شهر

Women's Health Outreach Program

High-resolution ultrasound and revision of previous bilateral mammogram.

Clinical summary: 49 years old female patient with Right breast lump with skin dimpling and nodule .

Detailed Findings

Right breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c)
- Right UOQ pathological process in form of speculated dense mass lesion measuring about 3.5 x2.8 x4.6 at AP , TS and CC associated with surrounding area of distortion , spiculations and asymmetry as well as skin dimpling reaching to the nipple , the whole process measuring about 5.6 x8.5 cm
- No suspicious microcalcification
- Ultrasound revealed an irregular heterogeneous hypoechoic mass lesion with posterior acoustic shadowing and internal vascularity seen at 9-10 O'clock measuring about 2.8 x3.4 cm with ductal extension to the nipple and reaching to skin
- Multiple (more the three) level I enlarged pathological axillary lymph nodes with globular shape and effaced hila , the largest measuring about 1.6 x1.3 cm with increased cortical thickness about 6 mm

Left breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- No solid or cystic lesions seen
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right UOQ highly suspicious spiculated mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. True cut biopsy is recommended
- Aslo CESM is recommended
- Right breast (BIRADS 1): normal study of the breast

Much obliged,

Dr. Rania Mostafa

Dr. Nourhan Osama , MD



N H T M R I

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name:	رشا النور يونس احمد بلوي	Age: 48 years	Sex: female
Request type:	مبادره	Sub request type:	
Hospital no:		Pathology no.:1037B-2026	
Department:	صحه مرأه	Date of result:29/9/2026	
Referred by:	د/هداية نور	Date of biopsy:24/9/2026	
Nature of specimen:	tru-cut biopsy	I.D. Number:27810222103707	
Clinical diagnosis:	Right breast mass		

Gross pathology:

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is moderate number of mitotic figures. Ductal carcinoma insitu component (solid subtype and comedo subtypes) of low to intermediate grade could be seen.

Immunohistochemical Result

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

Her2: Moderate complete membranous staining of >10% of tumor cells (score

2+)Equivocal for SISH

Ki67: Positive nuclear staining in 40% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass ,Tru-cut biopsy :
Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D